ARAÇ 5 / 5

Planlama Hataları Radarı

Bir vakayı uzatan hataları braketleri yapıştırmadan önce görün: yedi grupta 20 hata, her biri belirti, neden ve önlemle.

BÖLÜM 1

20 Planlama Hatası

Her satırı okuyun: belirtiyi tanıyın, neden süre kaybettirdiğini görün, önlemi plana yazın.

> *Tedaviyi uzatan hataların çoğu mekanikte değil, planlamada başlar. Braketten önce yakalanan hata, aylar kazandırır.*

1 · Teşhis

HATA	BELİRTİ	NEDEN UZATIR	ÖNLEM
01 **Fonksiyonel kaymayı atlamak**	Tedavi ortasında kapanış "değişir"; ön çapraz kapanış veya Sınıf III geri gelir.	Yanlış sagital ve transversal hedefe çalışılır; plan yarıda değişir.	Sentrik ilişkide kontrol edin; CR–CO farkını kaydedin (Araç 3).
02 **Panoramikte eksik, gömülü veya süpernümerer dişi kaçırmak**	Kanin sürmez, boşluk kapanmaz, sayılar tutmaz.	Mekanik ve çekim planı baştan kurulur; ek cerrahi süre gerekir.	Araç 1 ile tam tur; konum belirsizse ek görüntüleme.
03 **Başlangıç kök durumunu kaydetmemek**	Ara panoramikte kısa kök veya rezorpsiyon görülür, nedeni bilinmez.	Kuvvetler azaltılır, tedavi duraklar; hedef küçültülür.	Kısa, künt ve dilasere kökleri baştan işaretleyin; riskli dişte hafif kuvvet ve ara kontrol.
04 **Yüzü değil sadece dişleri planlamak**	Dişler dizilir ama profil veya dudaklar kötüleşir.	Hedef yeniden yazılır; çekim veya ankraj kararı değişir.	Problem listesine önce yüzü yazın; profil ve gülümseme fotoğrafı ile karar verin.

2 · Yer

HATA	BELİRTİ	NEDEN UZATIR	ÖNLEM
05 Yer analizini Bolton olmadan yapmak	Bitirmede boşluk kalır veya overjet kapanmaz.	Bitirme haftalarca uzar; IPR veya restoratif çözüm sonradan eklenir.	Başlangıçta Bolton hesaplayın; IPR veya restoratif planı Aşama 2'ye yazın.
06 Çekim kararını ertelemek	"Başlayalım, bakarız"; kesiciler önce öne gider, sonra geri alınır.	Çift hareket süreyi uzatır, kök rezorpsiyonu riskini artırır.	Karar Haritası (Araç 2) ile braketten önce karar verin.
07 Kanin bölgesinde fazla genişletmeyle yer kazanmak	Ark genişler, dişeti incelir; pekiştirme sonrası çapraşıklık döner.	Nüks yeniden tedavi demektir; periodontal sorun eklenir.	Kanin arası genişliği koruyun; yer ihtiyacı büyükse çekim veya distalizasyon.

3 · Ankraj

HATA	BELİRTİ	NEDEN UZATIR	ÖNLEM
08 Ankraj ihtiyacını hesaplamamak	Molarlar öne kayar, overjet kapanmaz, boşluk kapanırken Sınıf II artar.	Ankraj kaybı sonradan telafi edilir; mekanik uzar.	Minimum / orta / maksimum ankrajı Aşama 2'de yazın; aracı baştan seçin.
09 Mini vidayı geç eklemek	Boşluk kapatma aşamasında ankraj kaybı fark edilir.	Kaybedilen mesafe yeniden kazanılır; ek randevu ve süre.	Maksimum ankraj gerekiyorsa mini vidayı plana baştan koyun.
10 Asimetrik ankraj ihtiyacını görmemek	Bir tarafta Sınıf I, diğerinde Sınıf II kalır; orta hat kayar.	Bitirmede asimetrik elastik ve ek mekanik gerekir.	Sağ ve sol molar–kanin ilişkisini ayrı yazın; tarafa özel ankraj planlayın.

4 · Vertikal

HATA	BELİRTİ	NEDEN UZATIR	ÖNLEM
11 Yüksek açılı hastada ekstrüzyon mekaniği	Açık kapanış artar, çene ucu geriye döner, profil kötüleşir.	Vertikal kontrol için ek aparey ve süre gerekir.	FMA'ya bakın; Sınıf II elastiklerini ve molar ekstrüzyonunu sınırlayın.
12 Derin kapanışı açmadan sagital düzeltmeye geçmek	Alt braketler kopar, overjet kapanmaz.	Kopmalar ve tekrar yapıştırma tedaviyi uzatır.	Önce Spee eğrisini düzeltin, derin kapanışı açın; sonra sagital düzeltme.

5 · Transversal

HATA	BELİRTİ	NEDEN UZATIR	ÖNLEM
13 İskeletsel darlığı dental genişletmeyle çözmeye çalışmak	Posterior dişler bukkale yatar, çapraz kapanış nükseder.	Kaybedilen tork ve nüks yeniden tedavi gerektirir.	Darlığın kaynağını belirleyin; iskeletselse sütür durumuna göre RME planlayın.
14 Genişletmeyi seviyelemeden sonraya bırakmak	Ark teliyle transversal düzeltme aylarca sürer.	Seviyeleme ve genişletme sıralı yapılır, paralel değil.	Genişletmeyi tedavinin başına koyun.

6 · Mekanik

HATA	BELİRTİ	NEDEN UZATIR	ÖNLEM
15 Braket pozisyon hatalarını geç fark etmek	Bitirmede çok sayıda büküm, kök paralelliği bozuk.	Bitirme aşaması uzar; yeniden pozisyon geç yapılır.	Ara panoramikte kök paralelliğine bakın; yeniden pozisyonu erken yapın.
16 Tel dizisini atlamak	Çok erken kalın çelik veya tork; braket kopar, rotasyon kalır.	Kopmalar ve geri dönüşler süreyi uzatır.	NiTi ile seviyeleyin, sonra çelik; tork ve TMA aşamasını planlayın.
17 Rotasyon ve torku bitirmeye bırakmak	Son aylarda düzeltilecek çok şey birikir.	Bitirme beklenenden uzun sürer.	Rotasyonları seviyelemede, torku boşluk kapatmadan önce ele alın.

7 · Hasta uyumu

HATA	BELİRTİ	NEDEN UZATIR	ÖNLEM
18 Uyuma bağlı planı uyum sınamadan kurmak	Elastik ve aparey düzenli takılmaz.	Sagital düzeltme ilerlemez; plan değişir.	Uyumu ilk ayda ölçün; gerekirse uyum gerektirmeyen seçeneğe (mini vida, sabit fonksiyonel aparey) geçin.
19 Ağız hijyeni kriteri koymamak	Beyaz lezyon, dişeti büyümesi, kopan braketler.	Tedavi duraklar; erken söküm gündeme gelir.	Braketten önce hijyen kriteri ve eğitimi; her kontrolde kayıt.
20 Süreyi ve pekiştirmeyi baştan konuşmamak	Hasta randevuları atlar, tedaviyi erken bitirmek ister.	Aralar uzar, hedefe ulaşılmadan söküm istenir.	Aşamaları, tahmini süreyi ve pekiştirme planını ilk görüşmede anlatın.

BÖLÜM 2

Braketten Önce: Son Kontrol

Yazdırın; her vakada braket yapıştırma randevusundan önce işaretleyin.

Hasta / tarih

Teşhis

- [ ] Sentrik ilişki kontrol edildi; fonksiyonel kayma kaydedildi
- [ ] Panoramik Araç 1 ile tam tarandı; kök durumu kaydedildi
- [ ] Profil ve gülümseme problem listesinde

Yer ve ankraj

- [ ] Yer analizi ve Bolton hesaplandı
- [ ] Çekim kararı verildi (Araç 2)
- [ ] Ankraj ihtiyacı ve aracı yazıldı; mini vida gerekiyorsa planda
- [ ] Sağ ve sol molar–kanin hedefi ayrı yazıldı

Vertikal ve transversal

- [ ] FMA'ya göre ekstrüzyon riski değerlendirildi
- [ ] Derin kapanışı açma adımı sagital düzeltmeden önce
- [ ] Transversal sorunun kaynağı belirlendi; genişletme tedavinin başında

Mekanik

- [ ] Tel dizisi ve aşama sırası yazıldı (Araç 4)
- [ ] Ara panoramik tarihi belirlendi

Hasta

- [ ] Ağız hijyeni kriteri karşılandı
- [ ] Uyum gerektiren apareyler, süre ve pekiştirme anlatıldı

Eğitim amaçlıdır. Bu materyal klinik muayenenin, hekimin kararının ve uzman görüşünün yerini almaz.

Sonraki adım

Radarda işaretlediğiniz hatanın konusunu **Modül 03 Klinik Planlama: Problem Listesinden Mekaniğe** içinde açın. Aynı hataların gerçek vakalarda nasıl göründüğünü görmek için **Modül 09 Yorumlu Klinik Vakalar**.